

ITEM 144 : FIEVRE AIGUË

Fièvre = hausse de la température centrale au-dessus des variations normales circadiennes = $\geq 38^{\circ}$ le matin ou $\geq 38,3^{\circ}$ le soir

- **Fébricule** : hausse de température $> 37,5^{\circ}$ mais $< 38^{\circ}$
- Evolution : - **Aiguë** < 5 jours : généralement de cause infectieuse
 - **Prolongée** > 20 jours : $< 50\%$ de cause infectieuse
- Conditions de prise de température : à distance des repas, après 20 minutes de repos, par **voie axillaire** ou **buccale** (ajouter $+0,5^{\circ}\text{C}$ pour obtenir la température centrale) ou par **voie tympanique**
- Reflet de la réponse hypothalamique (centre de la thermorégulation) à l'agression tissulaire : en réponse à des substances pyrogènes exogènes et endogènes (cytokine...)
- Non synonyme d'infection : - Infection sans fièvre : **toxi-infection** (choléra, tétanos...), **infection chronique** (ostéite...)
 - Infection avec hypothermie : **bactériémie à BGN ++**

Gravité	Signes cliniques de gravité	Sepsis grave : - Neurologique : angoisse, agitation, confusion, troubles du comportement, prostration, coma - Cardiovasculaire : FC $> 120/\text{min}$, PAS < 90 mmHg (ou $\searrow$ de 40 mmHg), PAM < 65 mmHg - Cutané : purpura, extrémités froides et cyanosées, marbrures - Respiratoire : polypnée $> 24/\text{min}$, tirage, balancement thoraco-abdo, polypnée superficielle, $\text{SaO}_2 < 90\%$ - Rénal : oligurie < 5 mL/kg/h ou anurie
	Terrain à risque	- Femme enceinte : risque de souffrance/mort fœtale, fausse couche spontanée, prématurité - Immunodépression : déficit humoral (hypogammaglobulinémie, splénectomie, asplénie fonctionnel (myélome, drépanocytose)), déficit cellulaire (VIH, lymphopénie T), neutropénie, traitement immunosuppresseur, corticothérapie prolongée
	Co-morbidité	= Insuffisance cardiaque, respiratoire ou rénale, patient âgé et/ou polypathologique - Retentissement neurologique : troubles du comportement, convulsions, délire, coma - Déshydratation : $\nearrow$ des pertes hydriques de 400 mL/degré au dessus de 37°C - Décompensation cardio-respiratoire : - $\nearrow$ de la FC et FR de 10 bpm/degré au dessus de 37°C - Majoration des besoins en oxygène
Démarche diagnostique	Int	- Contexte : voyage récent, notion de contagion, post-opératoire, prise de risque (sexuel, toxicomanie...) - Profession (exposition aux animaux, eaux usées...), loisirs (baignade en eau douce (leptospirose), forêt (tiques)...) - Terrain : matériel prothétique vasculaire, valvulaire ou articulaire, cathéter vasculaire - Prise médicamenteuse
	C	- Neurologique : syndrome méningé, céphalées, signes de focalisation - Ophtalmologique : conjonctivite, purpura conjonctival, ictère - ORL : rhinorrhée, angine, douleur à la pression des sinus maxillaires ou frontaux, examen tympanique - Pulmonaire : toux, dyspnée, expectoration, signe auscultatoire - Cardiaque : recherche d'un souffle, frottement - Abdominal : diarrhée, signe de Murphy, défense, contracture, hépatosplénomégalie - Urinaire : brûlure mictionnelle, douleur à la percussion lombaire, douleur prostatique au TR, BU - Génital : leucorrhée, douleur à la mobilisation des annexes - Cutané : éruption, érysipèle, escarre d'inoculation, plaie d'allure infectée, cicatrice inflammatoire ou purulente - Palpation des aires ganglionnaires - Ostéo-articulaire : impotence fonctionnelle, épanchement, point douloureux rachidien, plaie du pied (diabète) - Présence de matériel étranger : sonde urinaire, cathéter veineux centrale ou périphérique, pacemaker, dérivation ventriculaire...
	Selon le terrain	Femme enceinte - Pyélonéphrite à rechercher systématiquement, surtout au 3 ^{ème} trimestre - Recherche d' infection abdominale de forme trompeuse - Recherche de listériose systématique par hémocultures - Notions de contage de toxoplasmose, rubéole, CMV ou varicelle
		Sujet âgé - Symptomatologie souvent atypique, pauci-symptomatique , dominée par des manifestations générales et neurologiques (état confusionnel) - Fièvre possiblement absente en cas d'infection - Prévalence supérieure des infections pulmonaires, urinaires et digestives
		Immuno-déprimé - Déficit humoral : bactérie encapsulée = pneumocoque, méningocoque, Haemophilus - VIH : - CD4 $< 200/\text{mm}^3$: recherche d'infections opportunistes - CD4 $> 200/\text{mm}^3$: infection bactérienne fréquente, notamment à pneumocoque - Neutropénie de courte durée : entérobactérie, staphylocoque, streptocoque, entérocoque - Neutropénie de longue durée : Pseudomonas aeruginosa, fongique (Candida, Aspergillus)

Démarche diagnostique	Selon le terrain			- Prothèse valvulaire : hémoculture systématique à la recherche d'une endocardite infectieuse - Chirurgie récente : recherche systématique d'une infection du site opératoire - Diabète : risque ↗ d'infection à S. aureus (notamment cutanée : plaie du pied) et d'infection du site opératoire - Cirrhose = 25% de décès par infection : infection invasive à pneumocoque, infection du liquide d'ascite - Toxicomanie IV : infection staphylocoque surtout, possiblement à Pseudomonas aeruginosa et Candida sp - Retour d'une zone d'endémie palustre : toute fièvre au retour des tropiques doit faire éliminer un paludisme et impose la réalisation d'un frottis et d'une goutte épaisse
	Indications d'hospitalisation			- Signes de gravité : sepsis grave/choc septique - Terrain à risque : femme enceinte, décompensation de comorbidité, immunodépression - Difficulté de prise orale des antibiotiques : troubles de déglutition... - Isolement social, difficultés d'observation prévisibles (éthylisme chronique...) - Absence d'amélioration malgré réévaluation et/ou adaptation thérapeutique à 48-72h
	PC	Aucune indication		- Fièvre aiguë isolée, bien tolérée, chez un sujet jeune sans comorbidité, sans foyer bactérien évident, ne revenant pas d'une zone d'endémie palustre (se méfier d'un VIH) - Infection bactérienne localisée évidente cliniquement, non compliquée, accessible à une antibiothérapie probabiliste : otite, sinusite, angine streptococcique, érysipèle... - Tableau viral évident, bénin, bien toléré : virose saisonnière, fièvre éruptive infantile, bronchite...
		Fièvre persistante sans étiologie évidente	< 72h	- Si bilan clinique négatif : rassurer le patient et le revoir à 48h si la fièvre persiste → Aucune indication d'antibiothérapie sans foyer infectieux ni en test diagnostique
> 72h			- Hémocultures prélevés avant toute antibiothérapie - Bilan standard : NFS, iono, urée, créatininémie, bilan hépatique, BU, RP - GDS, lactatémie, TP : si signes de gravité - CRP, PCT : aucun intérêt en cas de diagnostic évident, mais peut orienter vers une étiologie virale ou bactérienne selon la situation	
Synthèse diagnostique et thérapeutique	Point d'appel infectieux évident	- Traitement adapté à l'étiologie - En ambulatoire ou hospitalisation selon la gravité, le risque de complication, le terrain, la voie d'administration du traitement et la nécessité d'une surveillance - Réévaluation systématique à 48-72h, notamment en cas de traitement ambulatoire		
	Absence de point d'appel évident	Sans signe de gravité	- Enfant, adulte jeune : généralement virose, guérison spontanée en moins d'1 semaine - Terrain à risque : hospitalisation souvent nécessaire pour surveillance rapprochée et possiblement indication d'antibiothérapie probabiliste	
		Avec signes de gravité	= Sepsis grave : généralement d'origine pulmonaire, urinaire ou abdominale - Antibiothérapie probabiliste et remplissage vasculaire - Scanner thoraco-abdomino-pelvien en urgence dès stabilisation du patient	
	Etiologie non infectieuse	Syndrome d'hyperthermie	- Coup de chaleur : exercice physique en conditions de température élevée - Personne âgée dépendante et polymédiquée en période de canicule - Médicamenteuse : syndrome malin des neuroleptiques, ISRS, antiparkinsoniens - Endocrinopathie (exceptionnelle) : thyrotoxicose, phéochromocytome	
			- SRIS : chirurgie majeure, polytraumatisme, hématome volumineux, hémorragie méningée, pancréatite... - Accident thrombo-embolique - Contexte inflammatoire : lupus, maladie de Still, SAPL, DRESS syndrome, érythrodermie... - Néoplasie : nécrose tumorale, cancer multi-métastatique, hémopathie maligne aiguë...	
TTT	Mesures associées	- Traitement spécifique selon l'étiologie infectieuse - Lutte contre la déshydratation : boisson abondante et variée, sucrée et salée		
	Anti-pyrétique	= Non systématique : la fièvre augmente les défenses et permet le suivi de l'évolution et du traitement - Indication : fièvre mal tolérée ou sur terrain particulier (insuffisant cardiaque/respiratoire, sujet âgé) - Administration systématique et régulière (évite les rebonds de fièvre) - Paracétamol : - 15 mg/kg x 4/j chez l'enfant, jusqu'à 1 g x 4/j chez l'adulte, oral dès que possible - Contre-indication : hépatite aiguë, insuffisance hépatique - Aspirine et anti-inflammatoire non recommandés : risque de syndrome de Reye en cas de virose chez l'enfant, risque de complication loco-régionale ou systémique grave en cas de foyer bactérien		
	Antibio-thérapie	- Indication d'antibiothérapie urgente devant une fièvre sans diagnostic: - Sepsis grave/choc septique - Patient asplénique - Neutropénie - Purpura fulminans - Autre immunodépression ou décompensation : urgence diagnostique (avant antibiothérapie)		